

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: ERS

1. Identificación del Instrumento

Título original	Escala para la Evaluación del Riesgo Suicida (ERS)
Título español	Escala para la Evaluación del Riesgo Suicida (ERS)
Sigla	ERS
Autores originales	Marly Johana Bahamón Muñetón y Yolima Alarcón-Vásquez
Año original	2018
Adaptador español	Originalmente desarrollada en español (Colombia)
Año adaptación	2018
Formato	Cuestionario autoadministrado de 20 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La ERS fue diseñada como un instrumento psicométrico robusto para identificar y diagnosticar el nivel de riesgo suicida en adolescentes y adultos hispanohablantes. Se fundamenta en un modelo cognitivo-conductual y psicosocial del comportamiento suicida, el cual concibe al suicidio no como un fenómeno aislado, sino como el resultado de una interacción compleja entre desesperanza, ideación depresiva, intentos previos y la percepción de soporte/afecto familiar y social.

3. Características Generales

Objetivo	Detectar y clasificar el nivel de riesgo suicida considerando aspectos afectivos, cognitivos y relacionales.
Población	Adolescentes (desde los 12 años) y adultos.
Administración	Autoadministrado o aplicado en entrevista de cribado (aprox. 5 minutos).
Tiempo	Estimado entre 3 y 5 minutos.
Corrección	Suma directa de los 20 ítems (rango global: 20-120).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Depresión y desesperanza	1 al 6 (Falta de planes a futuro, visión triste, infelicidad, autopercepción de fracaso)	Evalúa sentimientos de vacío existencial, indefensión y falta de proyección de futuro.

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Ideación, planeación y autolesión	7 al 12 (Pensamiento de quitarse la vida, planeación activa, intentos previos, autolesiones)	Evalúa la presencia de cogniciones activas e intentos prácticos dirigidos a terminar con la vida.
Aislamiento / soporte social	13 al 16 (Sentimiento de soledad, dificultad de confianza, falta de red de amigos, marginación)	Evalúa el nivel de desconexión social y el sentimiento subjetivo de aislamiento.
Falta de apoyo familiar	17 al 20 (Percepción de desinterés familiar, distancia relacional, exclusión en el núcleo familiar)	Evalúa la ausencia de soporte percibido y la presencia de conflictos críticos familiares.

5. Sistema de Puntuación

Los 20 ítems se puntúan mediante una escala Likert de 6 puntos: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Parcialmente en desacuerdo, 4 = Parcialmente de acuerdo, 5 = De acuerdo, 6 = Totalmente de acuerdo. La puntuación total es la suma simple de todos los ítems, oscilando entre 20 y 120 puntos. No contiene ítems invertidos.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las puntuaciones globales de la escala se interpretan de forma continua, donde un mayor puntaje representa mayor gravedad del riesgo. Los baremos de corte en percentiles permiten clasificar el riesgo en tres categorías básicas:

- * Riesgo Bajo / Sin Riesgo (Puntuaciones bajas / Percentil inferior a 50).
- * Riesgo Moderado (Percentiles 50 a 85): Requiere intervención preventiva y apoyo terapéutico secundario.
- * Riesgo Alto (Percentil mayor a 85): Requiere la activación inmediata de un protocolo de emergencia clínica en salud mental.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El diseño de la ERS demostró excelentes propiedades psicométricas en su validación en adolescentes colombianos, reportando un Alfa de Cronbach global de 0.90 y coeficientes superiores a 0.75 para cada una de las cuatro dimensiones. El análisis factorial confirmatorio ratificó un modelo de cuatro factores que explica el constructo de riesgo suicida de forma integral.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Al ser desarrollada en Colombia para la población adolescente hispanohablante, goza de una excelente validez transcultural para países de América Latina, con baremos y formulación lingüística natural para esta demografía.

9. Aplicaciones Prácticas

Tamizaje en colegios y universidades, centros de urgencias médicas, y atención psicológica primaria.

10. Fortalezas del Instrumento

- Evalúa tanto la ideación suicida directa como los factores psicosociales amortiguadores (familia/amigos).
- Escala Likert de 6 opciones que reduce el sesgo de la tendencia central.
- De rápida aplicación y puntuación directa.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Depende completamente del reporte sincero del paciente (riesgo de ocultación por temor a hospitalización).
- Debe integrarse siempre con una evaluación clínica detallada en caso de puntuaciones límite.

12. Consideraciones Éticas y Legales

La evaluación del riesgo suicida es un procedimiento altamente sensible que demanda confidencialidad estricta y, al mismo tiempo, el deber ético de romper la confidencialidad para proteger la vida si se identifica un riesgo grave inminente.

13. Síntesis Técnica General

La ERS es una escala de tamizaje efectiva y de alta sensibilidad clínica para diagnosticar el riesgo suicida integrando la vivencia emocional con la calidad del soporte afectivo del entorno.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Bahamón Muñetón, M. J., & Alarcón-Vásquez, Y. (2018). Diseño y validación de una escala para evaluar el riesgo suicida (ERS) en adolescentes colombianos. *Universitas Psychologica*, 17(4), 1-15.
- Bahamón Muñetón, M. J., et al. (2019). Estilos de afrontamiento como predictores del riesgo suicida en estudiantes adolescentes. *Revista Psicología desde el Caribe*, 36(1), 3-21.